

teams Pr Narjis 2

Alors, on va commencer la réunion, deuxième séance interactive. Désolé pour ce petit retard parce qu'on avait un petit souci technique. Je voudrais d'abord avoir un retour pour savoir si vous m'entendez bien, si tout le monde me reçoit.

OK, ça marche, bien. On va y aller. Donc, aujourd'hui, on va aborder la deuxième et dernière partie des cours que j'ai à traiter avec vous.

Les tumeurs du foie, les tumeurs hépatiques, puis les tumeurs de la voie biliaire. D'accord. On va commencer par les tumeurs du foie.

Je suppose que vous recevez déjà le diaporama. Enregistrez la séance. Oui, bien sûr, on va l'enregistrer.

Deux secondes. Voilà. Voilà, c'est bon.

C'est parti. Bien. Donc, on a démarré l'enregistrement.

On va y aller. Donc, les tumeurs du foie, on va essayer de ne pas trop rentrer dans les détails quand même parce que ce sont des cours qui sont un petit peu longs. Il y a trop de détails.

Ils ont déjà été traités sur le support que je vous ai laissé sur la plateforme de la faculté. Et donc, je vais insister sur les points qui me paraissent un petit peu délicats, les points qui me paraissent essentiels par rapport à ce cours-là, les tumeurs hépatiques. Voilà.

Donc, en introduction, en introduction, comme vous le savez, une tumeur, c'est une tumeur. Il n'y a pas une définition particulière pour les tumeurs hépatiques. Une tumeur est une grosseur qui est anormale, dure une prolifération de cellules cancéreuses.

On ne va pas y revenir. Donc, cellules cancéreuses ou cellules, autres cellules. Bien sûr, parce que comme on va le voir dans ce cours-là, quand on dit tumeur, ce n'est pas forcément un cancer.

Donc, il y a des tumeurs qui sont bénignes. Il y a des tumeurs qui sont malignes. C'est un groupe qui est extrêmement hétérogène.

Dans ce cours-là, j'ai essayé d'aller vers l'essentiel. Ce ne sont pas toutes les tumeurs hépatiques que vous avez dans ce chapitre-là. Ce serait impossible de pouvoir aborder avec vous, en deux heures et en 60 diapositives, toutes les tumeurs du foie.

Parce que si vous vous amusez à aller à la bibliothèque, vous verrez qu'il y a des bouquins. Il y a de gros bouquins qui traitent des principales tumeurs du foie. Ce sont des tumeurs qui sont très hétérogènes, qui sont très fréquentes, qui sont fréquentes et qui sont trop nombreuses pour être

cité en détail.

Donc, on va insister. On va essayer de les classer dans un but pédagogique, sans trop rentrer dans les détails, comme on dit. Donc, si on veut un petit peu résumer la chose, il y a des tumeurs qui sont bénignes.

Il y a des tumeurs qui sont malignes, qui sont des cancers. Il y a des tumeurs qui sont primitives. Ils naissent initialement au niveau du foie.

Il y a des tumeurs qui sont secondaires, qu'on appelle également métastase. Forcément, la prise en charge est très variable. Pourquoi? Parce qu'on a des tumeurs qui sont très variables.

La nature est différente. Les mensurations sont différentes. Le pronostic est différent.

L'évolution est différente. Et donc, forcément, la prise en charge et le pronostic sont différents. On peut avoir des tumeurs qui sont de très bons pronostics, qui sont des tumeurs bénignes, qui régressent complètement après un traitement adéquat ou qui nécessitent parfois même pas un traitement.

Donc, il y a un pronostic qui est très bon. Par contre, on a des tumeurs qui sont extrêmement sombres, extrêmement méchantes, extrêmement mauvaises, pour lesquelles la survie à 5 ans ou le pronostic est extrêmement fâcheux. Voilà un plan classique.

Introduction, classification des tumeurs hépatiques, puis les principales, je dis bien, les principales tumeurs bénignes, les principales tumeurs malignes et la conclusion. La classification est très importante. C'est sur cette classification qu'on va se baser pour faire ce cours-là.

Donc, il faut la connaître, cette classification. Alors, cette classification, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on a deux grands types de tumeurs du foie. On a les tumeurs qui sont dites bénignes et on a les tumeurs qui sont dites malignes.

Les tumeurs malignes, ce sont les cancers, comme vous le savez. Les tumeurs bénignes, elles sont déjà de deux ordres. On a des tumeurs bénignes qui sont soit infectieuses, soit non infectieuses.

Infectieuses, elles sont dues à la prolifération d'un germe particulier. C'est le cas du quicidatique, qui est extrêmement fréquent dans notre contexte et qui a été traité par un autre confrère, je suppose, par Professeur Brillat, si je me souviens bien du cours. Il y a les abcès du foie.

Ce sont des abcès amibiens qui sont dus à l'amibiase et les abcès apiogènes. Ce sont également des chapitres qui ont été traités dans notre cours, donc je ne vais pas insister dessus. Donc, ce sont les tumeurs bénignes infectieuses.

À côté, nous avons les tumeurs bénignes non infectieuses que l'on va traiter dans ce cours-là. Et

au sein de ces tumeurs bénignes non infectieuses, nous avons des tumeurs qui sont très fréquentes, mais dont le pronostic est souvent assez bon, à part l'adénome qui peut se Cancériser, comme on va le voir par la suite. Donc, on a les kystes biliaires, on a les hémangiomes bénins et on a les adénomes du foie.

Pour les tumeurs malignes, là aussi, on va avoir des tumeurs qui sont primitives, qui naissent initialement au niveau du foie, essentiellement le carcinome hépatocellulaire et le cholangiocarcinome. Le cholangiocarcinome sera traité en détail dans le chapitre suivant qu'on verra par la suite, qui sont les tumeurs biliaires. On va prendre les deux par biliaire.

Et puis, on a les tumeurs secondaires. Les tumeurs secondaires, ce sont les métastases, donc digestif, sein, poumon, mélanome, etc. Commençons tout d'abord par les tumeurs qui sont bénignes.

Pour rappel, nous allons voir les kystes biliaires, les hémangiomes bénins et les adénomes du foie. Commençons par le kyste biliaire. Le kyste biliaire est une lésion qui est très fréquente, qui touche quasiment 5% de la population générale.

C'est un kyste dont la paroi est fibreuse. Il est tapissé par des cellules de type biliaire. C'est un kyste qui ne va pas contenir de la bile.

Les cellules qui tapissent le kyste sont de type biliaire, mais le contenu est clair. Le contenu du kyste est clair. Il n'y a pas de bile dans le kyste biliaire.

On l'appelle le kyste biliaire par rapport à la nature des cellules épithéliales, par rapport à la nature des cellules qui vont tapisser la paroi du kyste. C'est pour ça qu'on parle de kyste biliaire et non pas parce qu'il contient de la bile. C'est important.

Une autre notion importante, c'est que ce kyste-là ne communique pas avec les voies biliaires. Il ne contient pas de bile. Il est juste tapissé par des cellules biliaires.

Il n'a aucune communication avec les voies biliaires. Le diagnostic est souvent fait de façon fortuite par l'imagerie, par une échographie, par un scanner. Souvent, la patiente consulte pour un problème X, c'est son médecin généraliste, ou c'est le gastroentérologue, ou c'est la gynécologue.

En faisant l'échographie, on tombe sur un kyste biliaire. Donc, image transsonique parfaite avec une paroi propre. Elle pose le problème, ça vous l'avez déjà vu, je suppose, elle pose le problème du diagnostic différentiel avec un kyste didactique de type 1, selon la classification d'Horary à l'échographie, parce que c'est quasiment le même aspect.

Le scanner, c'est pour quantifier, c'est pour donner des dimensions, c'est lorsqu'on a de gros kystes, d'accord? Et lorsqu'on a des symptômes qui sont atypiques, c'est dans ces cas qui sont un petit peu rares, qu'on peut demander un scanner. On peut compléter l'échographie par un

scanner. Donc là aussi, on voit un aspect qui est hypodense, kystique, typique, bien limité, ou dépend du foie gauche.

Ici, c'est un kyste qui est assez volumineux, qui refoule un petit peu l'estomac en arrière. Il occupe quasiment la totalité du foie gauche. L'évolution du kyste biliaire.

Le kyste biliaire peut se compliquer. C'est pour ça qu'on le traite d'ailleurs rarement, heureusement rarement, mais il peut se compliquer. Lorsque vous avez un kyste qui est énorme, comme celui qu'on vient de voir sur le scanner, le kyste peut saigner.

On parle d'hémorragie intrakystique. Le kyste peut s'infecter, il peut être contaminé par un germe, et le kyste va se transformer en l'équivalent d'un abcès du foie. C'est une infection d'un kyste biliaire qui était initialement sain.

Il peut comprimer les structures de voisinage, notamment lorsqu'on a affaire, comme j'ai dit, à des kystes biliaires qui sont de gros volumes, qui vont comprimer les organes de voisinage, notamment l'estomac qui est juste à côté. Pour le traitement, comme c'est un kyste qui est bénin, lorsqu'il est petit, lorsqu'il n'est pas compliqué, il n'y a pas de traitement particulier, il n'y a pas de surveillance particulière, donc on ne touche pas à ce kyste-là. Pourquoi ? Parce que c'est un kyste qui risque de jamais se canceriser.

Pour la question, est-ce que les kystes biliaires et les onguions disparaissent spontanément ? On n'a pas encore abordé les onguions. On est en train de parler des kystes biliaires pour l'instant. Donc, s'il vous plaît, question par question, par rapport à ce qu'on est en train de traiter, les kystes ne régressent pas.

Ils restent en place. Ils peuvent se compliquer, mais ils peuvent rester en place sans entraîner aucune complication. Ils ne vont pas régresser, ils ne vont pas disparaître spontanément.

Ils vont toujours rester là parce que ce sont des tumeurs tout simplement. Les tumeurs ne disparaissent pas spontanément. Ils ne vont pas fondre spontanément.

Mais l'évolution peut être marquée par une complication. Heureusement, les complications sont rares, mais elles sont possibles. Pour le kyste biliaire, lorsqu'il n'est pas compliqué, il n'y a rien à faire.

Vous le dites à la patiente pour qu'elle le sache tout simplement, mais il n'y a rien à faire. Lorsque le kyste est compliqué, dans ce cas-là, il faut y aller de façon chirurgicale pour enlever le kyste. Si le kyste s'éteint de façon abondante, si le kyste est infecté, si le kyste comprime un organe de voisinage, il faut opérer la patiente.

L'angiome ne disparaît pas, pour anticiper sur la question de votre camarade. L'angiome ne régresse pas, il reste sur place. C'est une lésion bénigne, très fréquente, à peu près 3% de la

population.

Plus souvent chez les femmes. La nature de la lésion, c'est une tumeur qui est vasculaire, mais qui est bénigne. Là aussi, c'est une tumeur qui ne va pas se canceriser.

Là aussi, souvent, ce sont des tumeurs asymptomatiques. Souvent, ce sont des tumeurs qui seront découvertes fortuitement à l'échographie. Lorsqu'on fait un check-up, lorsqu'on fait une échographie pour un autre problème, l'échographiste passe sa sonde sur le foie.

Il tombe sur une tumeur qui est vasculaire, qui est bénigne. Mais souvent, c'est un diagnostic qui est fortuit. L'évolution, là aussi, souvent stable, souvent asymptomatique.

Les complications, heureusement, elles sont très rares. Comme vous l'avez deviné, c'est une tumeur qui est vasculaire. Elle peut saigner, forcément.

Le risque vasculaire, le risque de saignement, il est présent. Mais c'est pour les tumeurs qui sont extrêmement volumineuses. On peut également avoir des thromboses, des intralésions aux seins de la tumeur, lorsque les tumeurs commencent à prendre beaucoup de volume.

La notion importante, c'est qu'il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas s'amuser à essayer de confirmer le diagnostic d'angiome. Si vous avez des images qui suggèrent la présence d'un angiome du foie, il ne faut pas le toucher.

C'est contre-indiqué. C'est même dangereux d'aller ponctionner, d'essayer de faire une ponction biopsie pour confirmer la nature histologique d'un angiome. Donc, ne pas ponctionner, ne pas faire de biopsies.

C'est contre-indiqué. C'est dangereux. Là aussi, pas de traitement, pas de surveillance, sauf lorsque vous avez des formes qui sont compliquées, sauf lorsque vous avez un saignement, lorsque vous avez des symptômes qui sont très parlants.

Dans ce cas-là, il ne faut pas opérer. Est-ce que les complications de l'angiome ne suffit pas à réaliser ça avant qu'ils se compliquent ? Non, parce que les complications, c'est extrêmement rare. Si on fait une balance, si on pèse les complications, le pourcentage de complications par rapport aux patients qui ne sont pas compliqués, les complications sont extrêmement rares.

C'est moins de 1%. Donc, si on s'amuse à opérer tous les patients qui ont des angiomes du foie pour moins de 1% de complications, on risque de plus compliquer les patients par une chirurgie qui est inutile par rapport à des patients qui vont éventuellement se compliquer. C'est pour ça qu'il ne faut pas soulever les angiomes.

La chirurgie du foie n'est pas évidente et même la chirurgie des angiomes n'est pas évidente. Forcément, il ne faudra pas les toucher. Excusez-moi deux secondes, parce que j'ai une urgence.

On est en train de m'appeler. Je prendrai deux secondes et je reviens à vous. Pardon, je reviens à vous parce que j'avais une urgence au téléphone.

Les angiomes, on ne les touche pas. On ne touche pas un angiome, on ne touche pas un kyste biliaire sauf s'ils sont compliqués. Retenez ça une fois pour toutes.

Si ça tombe comme question On ne touche pas les angiomes, on ne les opère pas sauf dans des formes compliquées. Également pour les kystes biliaires, c'est la même chose, même raisonnement. Ce sont des images pour vous montrer ce qu'est un angiome.

Vous avez en haut et à gauche une échographie qui montre la tumeur qui est hyper échogène au niveau du foie. Vous avez une IRM au milieu qui vous montre une image en hyposignal. Je pense que c'est en séquence T2 à l'IRM.

Et puis vous avez une image un petit peu peropératoire. Je suppose que c'est une patiente qui était programmée pour une cholecystectomie par voie stéioscopique. Vous voyez un petit peu la viscule biliaire sur le lit vésiculaire.

Et puis vous avez le chirurgien qui est en train de récliner le foie pour montrer au bout de sa pince un angiome du foie. Vous devinez très bien qu'un petit angiome vasculaire comme celui-là, on ne va pas le toucher parce qu'il ne va pas se compliquer, il ne va pas se Cancériser. Il peut se compliquer, mais c'est très, très rare.

Il ne faudra pas le toucher sauf s'il est bien sûr compliqué. Dans ce cas-là, c'est un angiome qui est simple. Donc l'angiome n'a pas été touché, la cholecystectomie a été faite et la patiente n'a pas eu besoin d'une prise en charge secondaire pour son angiome.

Par contre, pour l'ADN et le plateau cellulaire, c'est différent. Là, c'est une autre histoire. C'est un tumeur qui est rare, heureusement, par rapport aux angiomes et par rapport au kyste biliaire.

Là aussi, c'est un tumeur qui est fréquent chez la femme jeune, entre 20 ans et 50 ans. La femme en activité génitale. Pourquoi ? Parce que c'est favorisé par les contraceptifs oraux, par les osteoporogestatifs.

C'est pour ça que c'est plus fréquent chez les femmes en période d'activité génitale. C'est une lesion tumorale hépatocytaire bénigne. Vous avez des cellules, des hépatocytes qui vont proliférer de façon bénigne.

Ce n'est pas encore un cancer. C'est un adenome, c'est une tumeur qui est bénigne. Là, c'est différent.

Là, vous avez des images qui sont suggérées à l'échographie ou au scanner, mais qui nécessitent obligatoirement une confirmation histologique. Vous avez des images, une image hypodense, l'image qui est à gauche, et l'image qui est rehaussée de façon rapide et intense

après injection de produits contrastes. Pourquoi faudra-t-il les caractériser sur le plan histologique ? Parce qu'il faudra les traiter.

Pourquoi faudra-t-il les traiter ? Parce qu'ils risquent de se Cancériser. C'est la principale différence par rapport au kyste biliaire et par rapport aux angiosarcomes. Ce sont des tumeurs qui peuvent se compliquer de cancer.

Il faudra les confirmer histologiquement. Il y a également le risque d'hémorragie pour toute tumeur au niveau du foie, parce que le foie est un organe qui est richement vascularisé. Et forcément, à chaque fois que vous avez une tumeur qui se développe au niveau du foie, le risque hémorragique est présent.

Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez posé les diagnostics d'un adénome du foie ? Il faut tout d'abord arrêter les contraceptifs oraux, parce qu'ils favorisent chez les femmes la prolifération, comme on a dit, de ces adénomes. Il faut surveiller. Et pour toutes les tumeurs dont la taille est supérieure à 5 centimètres, toutes les tumeurs qui y confirment, tout adénome qui y confirme de façon histologique, la surveillance est par l'échographie.

On fait des échographies tous les 6 mois à 1 an, à peu près en fonction de la taille de l'adénome. Ça se fait par l'échographie de façon classique et par les symptômes aussi. Si la patiente présente des symptômes particuliers, s'il y a une aggravation des symptômes, s'il y a une augmentation rapide de la taille, il faudra opérer les patients.

Dès que la taille atteint 5 centimètres, il n'y a pas de discussion. Il faut aller opérer les patients de façon chirurgicale. Il faut faire un exercice chirurgical de l'adénome du foie.

Maintenant pour les tumeurs malignes. On a vu les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Pour rappel, les tumeurs malignes primitives, nous verrons essentiellement le carcinome hépatocellulaire et les tumeurs malignes secondaires qui sont les métastases.

Tout d'abord, par rapport au carcinome hépatocellulaire, c'est le cancer primitif le plus fréquent. Là, il y a une petite nuance parce que vous verrez dans l'IQCM que j'ai déjà posé les années précédentes. Lorsque j'ai dit quel est le cancer hépatique le plus fréquent, le cancer hépatique le plus fréquent en général, ce sont les métastases.

On parle de tous les cancers. Lorsqu'on parle du cancer primitif le plus fréquent, le primitif le plus fréquent, c'est le carcinome hépatocellulaire. La nuance est importante.

Le cancer le plus fréquent, ce sont les métastases. Le cancer primitif le plus fréquent, c'est le carcinome hépatocellulaire. Je vais faire une parenthèse.

Alors, ce carcinome hépatocellulaire, pourquoi est-ce qu'il est fréquent ? Il est fréquent parce qu'il survient le plus souvent sur la cirrhose. Lorsque vous avez un patient qui est suivi pour une cirrhose, et dans notre contexte, la cirrhose est souvent due aux hépatites, parce que vous l'avez

déjà vu en cours de gastroenterologie avec nos amis gastroenterologues. Lorsque vous avez un patient qui a une cirrhose, il faut faire très attention.

Ce sont des patients qui peuvent développer secondairement sur leur cirrhose un carcinome hépatocellulaire. Dans 75 à 80% des cas de carcinome hépatocellulaire, nous avons affaire à une cirrhose du foie qui a dégénéré vers un carcinome hépatocellulaire. C'est le cas le plus fréquent.

Plus rarement, on peut avoir un cancer sur une autre hépatopathie chronique, mais qui n'est pas cirrhotique parce que le foie peut être malade d'autre chose que la cirrhose. On peut avoir des hépatopathies chroniques comme les maladies de surcharge, les maladies métaboliques et tout le reste, qui peuvent être retrouvées dans des situations qui sont beaucoup plus rares par rapport aux malades qui sont cirrhotiques. Dans des cas extrêmes, exceptionnellement, on peut avoir affaire à un cancer qui se développe sur un foie qui est sain.

Un patient qui est tout à fait sain qui a un foie qui est tout à fait normal. Sur le foie tout à fait normal, vous avez un cancer, un carcinome hépatocellulaire qui va se développer. C'est une situation qui est extrêmement rare.

En France, c'est fréquent. C'est le plus fréquent chez l'homme parce que les enfants ont plus d'hépatites que les femmes. 12% des habitants chez l'homme, 2,4% chez la femme.

Il y a une forte augmentation de son incidence durant les 20 dernières années pour plusieurs explications à cela. Cela est dû, bien sûr, parce que comme on a dit, c'est la cirrhose qui est la cause la plus fréquente. Forcément, plus on a d'hépatites de type C, plus on a de cirrhose.

Et plus on a de cirrhose, plus on a de carcinomes hépatocellulaires. C'est tout à fait simple à expliquer. On a en plus une meilleure identification diagnostique.

On fait plus d'échographies. On fait plus de scanners. On a plus de moyens pour diagnostiquer les carcinomes précocement.

Si on a plus de moyens, on va identifier beaucoup plus de cancers. Et puis, bien sûr, les patients cirrhotiques vivent plus longtemps. S'ils vivent plus longtemps parce qu'ils sont mieux pris en charge, ils ont tout le temps pour développer un cancer.

C'est une conséquence malheureuse d'une meilleure prise en charge de la cirrhose, tout simplement. Sur le plan intompathologique, sans rentrer dans les détails, là aussi, parce que ce n'est pas le but du cours, il y a plusieurs types histologiques, plusieurs variantes histologiques de ce carcinome. Mais il y en a deux qui sont importantes à connaître.

Tout d'abord, le type fibrolamellaire. Pourquoi? Parce que c'est une forme qui survient sur un terrain particulier, chez un sujet qui est jeune et qui a un foie qui n'est pas cirrhotique. Et le plus

important, c'est un cancer qui est de meilleure pronostique par rapport aux autres types de carcinomes et pathocellulaires.

C'est important à connaître cette forme du fibrolamellaire. Et puis, vous avez cette forme particulière dans laquelle nous aurons une association entre à la fois la composante carcinome et pathocellulaire et la composante cholangiocarcinome. On parle alors d'hépatocholangiocarcinome.

Ce sont deux formes, deux variantes histologiques importantes à connaître. Voilà donc l'image histologique qu'on va passer dessus. Comment est-ce qu'on peut penser un cancer, un carcinome et un pathocellulaire chez un patient? Les circonstances sont différentes.

On peut avoir à faire un patient qu'on connaît porteur d'une cirrhose, qu'on a suivi pour sa cirrhose et chez qui on a diagnostiqué le cancer, le suivi de sa cirrhose. On peut avoir des images échographiques qui suggèrent tout simplement la présence d'un carcinome et d'un pathocellulaire. Là aussi, c'est un patient qui consulte pour un autre problème.

Lorsqu'on a fait l'échographie, on a diagnostiqué un nodule du foie qui s'est avéré être un carcinome hépatocellulaire. Et puis, on peut avoir des symptômes. Le patient peut avoir mal, peut avoir un nectar, peut avoir pas mal de choses qu'on verra par la suite qui vont faire que le patient, on a pu diagnostiquer chez lui un carcinome hépatocellulaire.

Les symptômes, en parlant de symptômes, quels sont les symptômes possibles d'un carcinome hépatocellulaire? Nous avons la douleur de l'hypochondre droit ou de l'épigastre en fonction du siège du cancer sur le foie gauche ou sur le foie droit. Nous avons un nectar cholestatique parce que les hépatocytes sont détruits donc ils ne remplissent plus leur fonction de cholestase et le patient va développer un nectar. On peut avoir une masse abdominale de l'hypochondre droit ou de l'épigastre lorsqu'on a affaire à des tumeurs qui sont très importantes.

Et puis, on a de l'acide que le patient peut présenter lorsque son foie ne fonctionne plus correctement, lorsque le patient est déjà en insuffisance hépatocellulaire. Et on a, bien sûr, les signes généraux. Quand c'est un cancer, on peut avoir l'amigrissement, l'atterrissement d'état général, l'asthémie, l'anorexie, les signes que vous connaissez tous.

L'imagerie est très importante. Nous avons deux examens de référence. Si on vous pose la question quels sont les examens de référence que vous demanderez chez un patient chez qui vous pensez à un carcinome hépatocellulaire, vous pouvez demander un scanner hélicoïdal et vous pouvez demander une IRM.

Ce sont les examens de référence. Pourquoi ce sont des examens de référence? Parce qu'ils vont vous montrer des images typiques, très spécifiques, du carcinome hépatocellulaire. Le signe le plus évocateur, c'est quoi? C'est un nodule qui est hypervascularisé au temps artériel précoce.

Ce sont les washings. C'est un nodule qui va prendre de façon très intense le produit de contraste de façon très précoce au temps artériel. Et puis, il va avoir un lavage très important.

Avec le lavage, c'est ce qu'on appelle le washout. Il va passer directement en hypodensité, en hypointensité, par rapport au parenchyme hépatique non tumoral, à la phase portale ou à la phase tardive. Donc, il va prendre de façon intense le produit de contraste à la phase artérielle.

Et puis, à la phase veineuse, il va relarguer de façon très importante. C'est ce qu'on appelle le washing et washout. Ce sont des signes qui sont très importants.

Au scanner, ça donne ça. Vous voyez sur l'image de gauche, au temps artériel, il a pris de façon intense le produit de contraste. Et puis, lorsqu'on est passé à la phase portale, vous voyez que le parenchyme hépatique est vascularisé, est opacifié, alors que le nodule, qu'on voyait au temps artériel, il s'est vidé complètement de son produit de contraste.

L'IRM, c'est la même chose. Vous avez le nodule qui prend intensément le produit de contraste. C'est la vascularisation, tout simplement.

Ce sont des tumeurs qui sont extrêmement vascularisées. Le foie, en lui-même, c'est un organe qui est très vascularisé. Et le carcinome hépatocellulaire est une tumeur qui est richement vascularisée.

Donc, elle va injecter de façon intense, elle va prendre de façon intense l'apport du produit de contraste et elle va relarguer de façon très rapide le produit de contraste. C'est une tumeur. Une tumeur, c'est ça au fait.

Elle absorbe de façon très rapide le produit de contraste et puis, elle l'évacue de façon très, très rapide. À l'IRM, c'est la même chose. Donc, washing et washout.

Confirmation. Là, deux cas de figure. Vous avez soit un patient qui a un foie sirotique, soit un patient qui n'a pas de foie sirotique.

Alors, quand est-ce qu'on va confirmer le diagnostic de carcinome hépatocellulaire sur un patient qui a un foie sirotique ? Lorsque vous avez un aspect typique à l'imagerie, un aspect typique, c'est-à-dire, c'est ce que je viens d'expliquer, le washing et le washout, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire de biopsie. Donc, si vous avez un aspect typique radiologique à l'IRM ou au scanner washing, washout, il s'agit vraisemblablement dans plus de 90% des cas d'un carcinome hépatocellulaire. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'aller avoir une preuve histologique.

Maintenant, si vous n'avez pas un aspect radiologique typique, si l'aspect est atypique, dans ce cas-là, il faut aller vers l'histologie, il faut faire une fonction de biopsie. Donc, foie sirotique, aspect radiologique typique, pas de biopsie. Aspect atypique, fonction de biopsie.

Maintenant, si le foie n'est pas sirotique, dans ce cas-là, il faut y aller. Il faut avoir une confirmation histologique parce que ce n'est pas très fréquent, c'est extrêmement rare. Autant, lorsqu'on a affaire à un foie qui est sirotique, on sait très bien que le carcinome hépatocellulaire est très fréquent.

Donc, si on a une imagerie qui concorde, on n'a pas besoin de faire de biopsie. Ici, dans tous les cas, si vous avez un foie qui n'est pas sirotique, il faut faire la production de biopsie du foie. Donc, reprenez ces réflexes-là, ils sont importants.

Voilà, ça résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Foie sirotique, foie non-sirotique. Foie non-sirotique, production de biopsie du foie pour retenir le diagnostic.

Foie sirotique, avec radiologie typique, on retient le diagnostic. Foie sirotique, avec radiologie atypique, il faut faire une production de biopsie du foie. Maintenant, une fois que le diagnostic est retenu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut traiter.

Il y a deux sortes de traitements, traitement curatif et traitement préventif, après avoir fait un bilan préthérapeutique, bien sûr. Alors, bilan préthérapeutique, ce n'est pas spécifique aux tumeurs du foie. C'est pour tous les cancers.

Une fois que vous avez posé le diagnostic d'un cancer, on passe toujours par un bilan préthérapeutique et puis par la suite, on peut proposer le patient pour un traitement. Bilan préthérapeutique, on évalue tout d'abord l'état du foie non-tumoral. Pourquoi ? Parce qu'il est possible qu'on propose le foie pour une résection chirurgicale.

Donc, si on propose au foie, le patient, pour une résection chirurgicale, on risque d'emporter une grosse partie du foie. Dans ce cas-là, il faut évaluer le foie qui n'est pas tumoral. Il faut se poser la question, est-ce que le foie qui n'est pas tumoral qu'on va laisser en place est, comment dirais-je, est compatible avec une vie qui est tout à fait normale ? si vous enlevez, parce que pour être carcinoïde, il faut enlever totalement la tumeur avec des marges qui sont conséquentes.

D'accord ? Et donc, si on s'amuse à enlever une grande partie du foie en laissant un tout petit bout de foie qui n'est pas compatible avec la vie, il ne faut pas le faire. D'accord ? il faut toujours évaluer l'état du foie qui n'est pas tumoral. Il faut également évaluer l'état du patient parce que ce sont des opérations chirurgicales qui sont extrêmement lourdes.

Il faut se poser la question, est-ce que le patient va supporter ces interventions chirurgicales lourdes ? D'accord ? Et puis aussi, évaluer l'extension tumorale, notamment grâce à la TDM, grâce à l'IRM, parce que parfois, les tumeurs elles s'étendent aux organes de voisinage et on peut être amené à faire des résections associées aux hépatectomies. Pour le traitement, traitement avisé, curatif, il y a trois sortes de traitements. Pour traiter, pour faire guérir un patient qui a un carcinome hypopharyngé, il y a trois types de traitements.

Soit la transplantation hépatique, soit l'exérèse chirurgicale, c'est-à-dire faire des hépatectomies, enlever une partie du foie, soit une destruction percutanée, soit qu'on va détruire, on va le voir par la suite, de façon scanobuidée ou radiobuidée la tumeur. Transplantation du foie, une fierté pour Marrakech, la première transplantation historique du foie au Maroc a été faite au CHU de Marrakech. C'est une notion qui est très importante, très intéressante et qui reste à être notée.

Alors l'indication, la transplantation du foie est une intervention qui est très complexe, très compliquée et donc il y a des indications précises pour cette intervention. Donc on ne va pas faire une transplantation chez n'importe quel patient. Donc les indications qui sont précises, tout d'abord, première condition, c'est que le patient doit être atteint par un médecin d'un carcinome et patate cellulaire sur cirrhose.

Donc ça c'est un. Et deuxième des choses, par rapport à la tumeur en elle-même, elle doit être localisée au foie. Donc il ne faut pas qu'il y ait une extension aux organes de voisinage.

Et la tumeur doit être soit unique, soit que vous avez une seule tumeur qui mesure moins de 5 centimètres, soit que vous avez deux, maximum trois nodules qui ne dépassent pas 3 centimètres. Et bien sûr, en l'absence de thrombose vasculaire portale ou sucépatique. Donc ça fait beaucoup d'indications, beaucoup de restrictions.

Donc tout d'abord, le foie doit être cirrhotique. Et ensuite, la tumeur doit être unique, soit qu'elle est, doit être localisée au foie déjà, donc pas d'extension aux organes de voisinage. Et elle doit être soit unique, moins de 5 centimètres, soit deux, maximum trois nodules qui ne dépassent pas 3 centimètres.

Il ne faut pas qu'il y ait de thrombose vasculaire portale ou sucépatique. Et donc, c'est très, très restrictif comme indication chirurgicale. À côté, nous avons les exéreses chirurgicales, ce qu'on appelle les hépatectomies.

Donc, elles sont indiquées chez les patients, chez qui on ne peut pas faire une transplantation hépatique, et chez les patients qui ne sont pas cirrhotiques, bien sûr. Il faut bien sûr que le foie restant, comme on l'a dit, soit viable. Idéalement, on fait une résection chirurgicale en respectant des marges anatomiques, des marges chirurgicales de 2 centimètres.

Donc, on fait des hépatectomies. Ce sont des détails techniques. Je ne vais pas vous poser des questions par rapport à la chirurgie du foie.

C'est extrêmement compliqué. Même pour des résidents en chirurgie, c'est compliqué. Donc, il n'y aura pas de questions par rapport aux détails techniques.

Donc, ce que je vous donne, c'est par rapport, c'est plus dans un cadre pédagogique et de culture générale. on ne va pas rentrer dans les détails techniques par rapport à ça. Troisième technique thérapeutique à visée curative, c'est la radiofréquence.

Donc, ce sont des techniques qu'on va faire chez nos patients sans ouvrir le patient. Donc, vous avez des centres qu'on va mettre au contact quasiment de la tumeur en étant guidés par l'échographie. On va envoyer nos ondes de radio à haute fréquence qui vont faire vibrer le foie et en faisant vibrer le foie au niveau de la tumeur, ils vont détruire la tumeur.

Une indication précise, c'est lorsque la tumeur mesure moins de 3 centimètres et qu'elle est accessible, bien sûr, à l'échographie et à la sonde, bien sûr, à condition qu'elle ne soit pas à côté d'éléments anatomiques nobles et dangereux, notamment l'huile du foie et les grosses voies biliaires pour ne pas entraîner de complications thérapeutiques ou iatrogènes. Traitement palliatif. Le traitement palliatif, bien sûr, c'est les oncolytiques, c'est la perfusion.

Pourquoi est-ce que la transplantation doit être sur un foie sérotique? Pourquoi? Parce que dans la sérotude du foie, on ne peut pas souvent, les lésions s'en diffusent. C'est l'indication idéale. Si vous avez un patient qui a un foie qui n'est pas sérotique, ça sous-entend qu'il a une partie du foie qui est peut-être encore fonctionnelle par rapport à un patient qui a un foie sérotique.

Lorsqu'on a un patient qui n'a pas un foie sérotique, si on s'amuse à faire une transplantation chez un patient qui a un foie non sérotique, ça serait du gâchis comme on dit. Donc le patient, il a une partie du foie qui est normale, qui est tout à fait normale et on va l'enlever. Il peut même vivre avec cette partie qui est normale.

Forcément, ce n'est pas une indication qui est idéale. C'est pour ça qu'on a limité la transplantation aux patients qui ont un foie sérotique. Pour revenir au traitement palliatif, c'est juste pour soulager le patient.

On ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, la dernière partie du cours, les métastases hépatiques. Les métastases hépatiques, comme j'ai dit, ce sont les cancers hépatiques les plus fréquents.

Tous types de cancers confondus. Ce sont les tumeurs malignes les plus fréquents du foie. Les primitifs, ils sont différents.

Souvent, ce sont les primitifs qui sont digestifs, notamment les cancers colorectaux, qui vont donner ces métastases au niveau du foie. On peut avoir d'autres lésions primitives, l'estomac, le pancréas, le sein, les mélanomes, etc. Notion de définition, on a des métastases soit synchrones, c'est-à-dire qu'ils sont diagnostiqués en même temps qu'au moment du primitif, soit métachrones, qu'ils apparaissent secondairement.

Vous avez un patient qui a été traité pour un cancer de l'estomac, par exemple, et qui secondairement a développé des métastases. Diagnostic, il est très variable. Souvent, vous avez cet aspect-là, cet aspect radiologique typique, ce qu'on appelle un lâchet de ballon.

Vous avez de multiples modules métastatiques au niveau du foie. Chez des patients pareils,

malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà.

Les métastases on n'a pas besoin de faire des biopsies sauf dans des cas particuliers. Donc, on peut se ramener à faire des biopsies de la métastase. Lorsque les métastases ont un aspect radiologique qui n'est pas spécifique.

Alors, une autre question. Pour un patient séreux, suite à une hépatite virale chronique, ayant bénéficié d'une transplantation hépatique, est-ce qu'il n'y a pas de risque que l'infection détruise le greffant? Je n'ai pas compris. On a enlevé le foie.

Lorsqu'on fait une transplantation hépatique, par principe, on fait une hépatectomie qui est totale. Et donc, si on fait une hépatectomie qui est totale, le foie qui était le siège de l'hépatite, il n'y a plus d'hépatite, il n'y a plus de foie tout simplement. Donc, on enlève le foie et on met un autre foie à la place.

Donc, forcément, il n'y a pas de risque d'infection par l'hépatite chez le patient. Voilà. Donc, pour les métastases, on a dit qu'il faudrait les confirmer lorsqu'on a un aspect qui est inhabituel des métastases, lorsque le primitif n'est pas connu, lorsque le primitif est très ancien, lorsqu'on a plusieurs antécédents de cancers qui sont différents et qu'on n'arrive pas à faire la part des choses entre les différents types de cancers, lorsqu'on a un objectif thérapeutique spécifique.

Le traitement, là aussi, est très variable. Il dépendra du type du primitif, il dépendra du siège de la métastase, il dépendra du nombre de métastases. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails qui seraient trop techniques par rapport à votre niveau.

Pour les métastases, les traitements sont aussi variables que les causes primitives. Il n'y a pas un traitement, mais deux traitements pour les métastases hépatiques. En conclusion, les tumeurs hépatiques peuvent être bénignes, peuvent être malignes.

Elles sont malheureusement dominées par les tumeurs malignes à type de métastase et de carcino-hépatocellulaire. La prise en charge est différente. L'imagerie a une place qui est très importante et le pronostic est variable en fonction du type de cancer.

Voilà, c'était le cours des tumeurs hépatiques. Je prends deux secondes pour aller au cours des tumeurs biliaires. On reprend avec les cancers de la voie biliaire.

Là aussi, j'ai essayé d'aller vite parce que vous avez déjà le support par rapport à ce cours-là. Je vais insister sur les choses qui sont importantes. Le cancer des voies biliaires, c'est une tumeur maligne qui dépend des voies biliaires.

Tout simplement, il y a des voies biliaires qui sont la voie biliaire qui est principale et vous avez la voie biliaire accessoire. Ça, vous l'avez déjà vu en anatomie. On va y revenir par la suite.

Souvent, des adénocarcinomes. Ce sont heureusement des tumeurs qui sont rares, mais

malheureusement, ce sont des tumeurs qui sont graves. La prise en charge est multidisciplinaire comme la plupart des cancers et l'imagerie a une place qui est importante.

Ça, c'est le plan pour le rappel anatomique et retenir juste une notion importante. Voies biliaires principales formées par les deux canaux hépatiques droit et gauche, le canal hépatique commun, le canal colédoque, voies biliaires accessoires formées par la visicule biliaire et le canal cystique. Dernière notion importante, c'est la voie biliaire principale.

Elle se termine au niveau de l'ampoule de Vatterre, au niveau du deuxième duo des normes. Ça, vous le savez déjà. C'est une notion qui est importante sur la face interne du deuxième duo des normes.

Classification. Comme on l'a vu, on peut classer ces tumeurs des voies biliaires en trois grands groupes. Vous avez les cancers de la voie biliaire principale.

Vous avez les tumeurs de la visicule biliaire. Et vous avez les ampullons vatteriens, les cancers de l'ampoule de Vatterre. Je vais juste insister sur les cancers de la voie biliaire principale pour parler de leur classification.

Vous avez des cancers qui se développent au sein du foie. Ce sont les cancers intra-hépatiques. Vous avez des cancers extra-hépatiques proximaux qui sont périhilaires autour du île.

Et vous avez des cancers extra-hépatiques qui sont à distance du île. L'épidémiologie, comme j'ai dit, ce sont des tumeurs qui sont rares, moins de 2, 2 000 cas par an en France. Les fréquences qui y varient, ce sont souvent des tumeurs du sujet âgé, 60 et 70 ans.

Le cholangiocarcinome, il est plus fréquent chez l'homme. Le cancer de la visicule biliaire, il est plus fréquent chez la femme. Les facteurs de risque, j'insiste sur la litiase biliaire.

C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez un patient qui a une litiase biliaire, il faut l'opérer le plus souvent. Pourquoi? Parce que ce sont des patients qui peuvent avoir ce qu'on appelle des néocalculs visiculaires. La litiase biliaire est très importante dans notre contexte.

À côté de la litiase biliaire, vous avez les autres causes que je vous laisse lire sur le cours. Maladie inflammatoire, l'alcool, les hépatites et la cirrhose. Le diagnostic de ces tumeurs-là, les signes sont extrêmement variables mais il y a deux signes à retenir.

Deux signes qui sont importants. Vous avez les lictères rétentionnels. C'est un lictère, retenez juste une source qui est d'un seul tenant, qui est insidieux, qui est progressif, qui est d'allure rétentionnelle mais c'est un lictère qui va s'installer de façon progressive et insidieuse.

Et puis, vous avez la douleur. La douleur, elle peut siéger au niveau de l'hypochondre droit, au niveau de la région épigastrique bien sûr, parce que c'est le siège du foie, le siège des veaux biliaires. Donc, deux signes importants à retenir, les lictères et la douleur abdominale.

L'examen abdominal, vous le savez déjà, l'hépatomégalie, la masse, l'acide, les signes généraux, vous les avez, les signes généraux classiques du cancer, l'amigrissement, l'anorexie, l'intéressons n'est pas général. Et puis, vous avez des signes qui ne sont pas spécifiques. Donc, la biologie, passons maintenant à la biologie.

La biologie, il y a des signes qui ne sont pas spécifiques qui sous-entendent que le foie est en train de souffrir. Donc, vous avez le syndrome de cholestase, notamment chez les patients qui sont ictériques avec augmentation de la bulle rubine totale, augmentation des gammes AGT, augmentation de phosphatase alcaline. Et vous avez le syndrome de cytolie.

C'est-à-dire que vous avez un foie qui est en train de souffrir, tout simplement. Vous aurez également une perturbation du bilan de démostase, donc, de la coagulation parce que le foie... Monsieur, est-ce que l'ictère rétentionnée est la même chose que l'ictère cholestatique ? Oui, c'est la même chose, exactement. L'ictère rétentionnée et l'ictère cholestatique, c'est la même chose.

Donc, vous avez une augmentation également des marqueurs tumoraux, notamment de l'ACE et du CA19-9 à la biologie. L'imagerie, il faut commencer par l'échographie parce que c'est l'examen le plus simple, le plus anodin, le plus rapide à avoir. Il peut vous donner des images assez classiques, surtout en matière de cancer de la viscule biliaire parce que vous avez un cancer de la viscule biliaire.

Le diagnostic, il est quasiment évoqué de plus de 80 % des cas, parce que vous aurez à faire à des lésions qui sont bourgeonnantes, des lésions qui vont faire protrusion dans la lumière vasculaire et qui peuvent même occuper toute la viscule biliaire. Donc, c'est très typique et très caractéristique. L'échographie est souvent suffisante pour ces tumors de la viscule biliaire.

Je dis bien la viscule biliaire. Pour la veublière principale, c'est plus une orientation qu'on va avoir. On va avoir une orientation par rapport à un tumor en montrant la dilatation de la veublière principale.

Pourquoi? Parce que la veublière principale est souvent masquée. Parce qu'il y a une grande portion de la veublière principale qui passe derrière le duodenum et derrière le pancréas. Donc, elle est extrêmement profonde et forcément, elle n'est pas accessible à l'exploration radiologique par échographie.

C'est pour ça qu'il faut confirmer par le scanner qui pourra confirmer les diagnostics et pourra également faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. Donc, vous avez une image scanographique qui montre une paroi vasculaire qui est épaissie avec l'extension au lit vésiculaire. Ici, vous avez un cancer de la veublière principale.

Donc, vous avez une masse qui est infiltrante au niveau de la région hilare du foie. L'IRM permet l'avantage de l'IRM par rapport au scanner c'est qu'elle permet de faire ce qu'on appelle une

cartographie. Donc, on va faire la BILI-IRM.

La BILI-IRM va vous montrer l'arbre biliaire en totalité en montrant en donnant avec précision la localisation et le siège exact de la tumeur. Donc, c'est ça l'avantage de la BILI-IRM par rapport au scanner. Et chez ces patients qui ont des tumeurs de veublière, souvent, on est amené à faire une IRM.

Après l'échographie, on demande directement l'IRM. En fait, ça dépend des patients. Lorsque vous avez un cancer de la viscula biliaire, souvent, la TDM est demandée parce que la TDM va caractériser mieux la viscula biliaire.

Lorsqu'on a affaire à un cancer de la veublière principale, la BILI-IRM est la meilleure. Pour la viscula biliaire, il vaut mieux commencer par la TDM. Pour la tumeur de la veublière principale, il vaut mieux commencer par une BILI-IRM.

Donc, vous voyez très bien que c'est une très belle BILI-IRM qui vous montre tout. Le 1, c'est la viscula biliaire. Le 2, ce sont les veublières intrahépatiques.

Le 3, vous avez une amputation. Vous avez quasiment une amputation du canal hépatique avec une grosse dilatation de la veublière principale en amont qui sous-entend qu'à ce niveau-là, nous avons forcément un obstacle. Le 4, c'est le canal du vireçon.

C'est le pancréas, en fait. Voilà, après avoir pensé à un cancer biliaire, après avoir confirmé le cancer biliaire, il faut proposer le patient pour le traitement. Bilan préthérapeutique, c'est, comme pour tous les cancers, toujours deux questions à se poser.

Est-ce que le patient est opérable? Est-ce que le patient va supporter la tumeur? Deuxième question, est-ce que le patient est résécable? Est-ce qu'on pourra enlever le cancer en totalité chez lui? Opérabilité, bien sûr, c'est l'examen clinique du patient, le bilan biologique, la visite chez l'anesthésiste. Là aussi, la volumétrie hépatique. Si vous avez à faire une hépatectomie majeure, se poser la question est-ce que le foie qui va rester est compatible avec une vie qui est normale.

Et pour la résécabilité, il faut voir si on pourra enlever la tumeur. Dans ce cas-là, on fait une bilirème, une colonosurgery ou une bilirème. C'est la même chose.

On fait une bilirème et on peut faire un scanner thoracopédien ou pévien. Pourquoi? Pour rechercher des métastases par rapport à ce cancer-là, notamment des métastases thoraciques et des métastases ganglionnaires péviennes. Le traitement, comment peut-on traiter ces patients? Les moyens thérapeutiques, c'est soit la chirurgie, soit les traitements médicaux, soit l'endoscopie.

L'attention automatique, vous le connaissez déjà, je ne vais pas insister dessus. Pour la chirurgie, c'est le seul traitement qui est curatif. Donc, si vous voulez traiter un patient d'un cancer de la voie biliaire, la chirurgie est le seul traitement curatif.

Donc, si je vous pose la question est-ce que la chirurgie est le seul traitement curatif pour le cancer des voies biliaires? Oui, la chirurgie est le seul traitement qui peut guérir, qui peut prétendre guérir le patient qui a une tumeur biliaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand est-ce que le cancer peut être réséquable? Le cancer, il est réséquable lorsqu'il n'y a pas de métastase déjà.

Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'il ne va pas envahir les organes de voisinage, ça, c'est deux. Et troisièmement, lorsqu'il ne veut pas, il n'y a pas d'envahissement vasculaire associé.

Donc, si j'ai, par exemple, une tumeur de la voie biliaire principale avec un envahissement de la veine porte ou avec un envahissement de l'artère hépatique, le patient ne pourra pas survivre à l'intervention. Donc, on ne pourra pas réséquer ça. Et donc, ça dépendra de l'extension loco-régionale et ça dépendra des métastases.

Si j'ai un patient qui a des métastases pulmonaires, alors quoi bon qu'ils ne sont pas réséquables? Alors quoi bon d'aller enlever la tumeur alors que je ne pourrais pas le guérir complètement? Donc, on résèque la tumeur lorsqu'on peut proposer un traitement qui va guérir le patient tout simplement. D'accord? Pour la transplantation hépatique, elle n'a pas d'indication formelle. Donc, l'indication formelle, elle est pour le carcinome hépatocellulaire.

C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour les tumeurs biliaires, il n'y a pas d'indication formelle. Il y a des essais thérapeutiques et certains centres hyper spécialisés aux Etats-Unis, au Japon, ou ailleurs, qui peuvent faire ça chez certains patients.

Mais, il n'y a pas d'indication formelle comme c'est le cas pour le carcinome hépatocellulaire. Le geste dépendra du siège exact et ce qu'il n'y a pas de transplantation de la vésicule biliaire. Non, mais on peut vivre normalement sans vésicule biliaire, mademoiselle.

Nous autres chirurgiens, nous passons nos journées à enlever les vésicules biliaires. Donc, si on s'amuse à faire des transplantations des vésicules biliaires, on passerait pour des criminels tout simplement. La vésicule biliaire est un organe biliaire accessoire.

C'est un réservoir. Donc, si on enlève la vésicule biliaire, on peut vivre tout à fait normalement sans avoir besoin de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est un réservoir, comme vous le savez.

D'accord? Donc, si on enlève la vésicule biliaire, on n'a pas besoin de transplanter une vésicule biliaire. Ça ne sert à rien tout simplement. Voilà.

Donc, pour revenir un petit peu aux gestes qu'on propose, les sièges curatifs qu'on propose chez ces patients qui ont des cancers de la voie biliaire. Donc, ça dépendra du siège. Si j'ai un cancer au niveau du foie, on va faire des hépatectomies comme ce qu'on avait tout à l'heure.

Lorsque j'ai une tumeur au niveau du île, là, je dois réséquer la voie biliaire principale et une partie du foie. Pourquoi? Parce qu'une partie du île pénètre intimement dans le parenchyme hépatique. Et donc, forcément, je dois associer les deux.

Et lorsque j'ai une tumeur extra-hépatique sur la voie biliaire principale mais qui est loin du foie, dans ce cas-là, j'enlève la vésicule biliaire et j'enlève la voie biliaire principale et je rebouche, je re-anastomose la voie biliaire principale sur une once déjeunale. Je fais monter une once déjeunale et je branche dessus ma voie biliaire principale. C'est ce que je vous ai mis sur le schéma.

Vous avez une tumeur, on a enlevé le cancer, vous avez une sténose, un rétrécissement tumoral. On a enlevé le rétrécissement tumoral et on a fait monter une once intestinale pour la brancher directement sur l'intestin grec. Le cancer de la vésicule biliaire, dans ce cas-là, il faut enlever la vésicule biliaire et il faut également enlever le foie qu'il y a autour.

On appelle ça une cholecystectomie élargie pour les vésicules biliaires. Et lorsqu'on a affaire à de grosses tumeurs de la vésicule biliaire, on peut même être amené à faire des hépatectomies. Donc enlever une partie du foie en emportant la vésicule biliaire avec une once, bien sûr.

Pour l'ampulon vatérien, l'ampoule de vatère est une zone carrefour contenant à la fois le canal colédoque, le canal de Viersong et une partie de la face interne du deuxième duodenum. Et comme vous le savez, ces tumeurs-là, le pancréas est enchâssé dans le duodenum. Donc si on veut prétendre guérir ces patients-là, il n'y a qu'une seule intervention à faire.

C'est ce qu'on appelle la duodenopancréatectomie céphalique. Je pense que vous avez déjà vu ça avec le prof qui vous a fait le cours du cancer du pancréas. C'est le fait d'enlever le cadre duodénal et la tête du pancréas.

C'est ce qu'on appelle la duodenopancréatectomie céphalique. Voilà. Donc réjection R0, c'est un petit peu juste pour vous donner une idée par rapport aux techniques chirurgicales.

Donc si la chirurgie n'est pas possible, on peut proposer aux patients pour des dérivations biliaires. Donc les dérivations biliaires, vous savez ce que c'est. Donc on prend une partie de la voie biliaire principale qui est saine.

On va la brancher avec une onse intestinale pour faire baisser un petit peu l'ictère, pour faire passer la biliaire directement vers l'intestin grêle, mais sans toucher la tumeur. Donc c'est juste à titre palliatif. D'accord? C'est juste pour soulager les symptômes du patient, pour faire baisser un petit peu son ictère, mais la tumeur, elle est là.

La tumeur, elle va rester là. Dernière remarque, vous voyez un petit peu la gravité du cancer, parce que vous voyez les chiffres de la survie, même après réjection R0. Réjection R0, c'est lorsque je n'ai pas laissé de résidus tumoraux en place.

Même après avoir fait un geste idéal R0, vous avez une survie à 5 ans qui ne dépasse pas 5 à 10 % pour le cancer de la biliaire et 10 à 40 % pour le cholangiocarcinome. Donc là, ça vous donne une idée par rapport au pronostic extrêmement sombre de ces cancers des voies biliaires. Donc, la survie, elle est vraiment médiocre.

Ce sont des cancers qui sont très, très graves, malheureusement. L'endoscopie, l'endoscopie, elle a une place palliative, là aussi. Donc, au lieu de faire une dérivation biliaire, je vais mettre des prothèses.

Je vais aller par voie endoscopique sur l'ampoule de VATR et je vais glisser comme un parapluie qui va s'ouvrir, je vais glisser une prothèse au niveau de la voie biliaire principale et en s'ouvrant, la prothèse va laisser la bile passer. Donc, là aussi, je ne vais pas toucher le cancer. C'est un traitement qui est strictement palliatif.

Je ne touche pas le cancer, mais je permets juste à la bile d'être drainée directement du foie vers le duodenum. Voilà. Donc, en conclusion, en conclusion, c'est un cancer qui est très méchant.

Le cancer des voies biliaires est extrêmement méchant. D'accord? Malheureusement, dans notre contexte, il est diagnostiqué à des stades qui sont avancés et donc le pronostic est encore plus sombre chez ces patients-là, malheureusement. Chez les rares patients qu'on peut opérer, la seule possibilité de survie est est-ce que les prothèses peuvent être envoyées par le cancer? Oui, les prothèses peuvent être envoyées par le cancer, malheureusement.

Donc, on doit être obligé de les remplacer si le patient survit, bien sûr, parce que comme j'ai dit, c'est un traitement qui est palliatif et la survie à six mois ou à huit mois ou à dix mois, elle est exceptionnelle. Et donc, souvent, ce sont des patients qui vont garder leurs prothèses jusqu'à la fin de leur vie. Ce sont des stades qui sont très avancés.

Voilà, malheureusement. Et oui, la prothèse, elle est envoyée par le cancer parce qu'elle sera repoussée et sera envoyée par le cancer au bout de quelques mois, malheureusement. Voilà, pour revenir à la conclusion, donc, le seul traitement agressif qui peut guérir le patient est de référence à la chirurgie.

D'accord? Alors, si vous espérez, si vous voulez espérer guérir un patient qui a un cancer de la vilière principale ou de la vésicule biliaire, il faut le proposer pour la chirurgie. Mais, grosso modo, c'est un cancer péjoratif qui est extrêmement méchant. Voilà.

Donc, je ne suis pas rentré dans les détails. Je suis resté sur les grandes lignes du chapitre des deux cours. D'accord? En plus, c'est le ramadan.

Donc, on arrive au terme des cours que j'ai traités avec vous. Je vous souhaite un très bon courage, incha'Allah. Pour les questions d'examen, ne vous en faites pas.

D'accord? Donc, moi, je ne rentre pas dans les détails techniques. Vous avez toutes les réponses dans les cours que je vous ai donnés. Vous avez toutes les réponses dans les mots que j'ai cités avec vous.

Vous pouvez repasser la discussion que je vous ai donnée. D'accord? Restez pragmatique et tout se passera bien, incha'Allah. Donc, voilà.

Très bon Ramadan et très bon courage pour la suite, incha'Allah.